

Próba *samoleczenia*

Kofeina, nikotyna, alkohol, marihuana, kokaina — mózg ADHD szuka dopaminy. To nie słabość — to objaw.

CZAS: 10 min refleksji Stosuj przy pytaniu „czy moje używanie to problem”

ŹRÓDŁO: Khantzian (1997, hipoteza samoleczenia); Wilens i wsp. (2011); Levin i wsp. (2007, 2015)

JAK UŻYWAĆ

Jeśli używasz substancji (kawa > 4x/dzień, nikotyna, alkohol codziennie, marihuana regularnie, leki bez recepty albo nielegalne) — zastanów się: **czego mózg szuka?** Stymulacji? Wyciszenia? Snu? Regulacji emocji? Zapisz wzorzec, porozmawiaj z lekarzem prowadzącym ADHD *lub specjalistą/tką uzależnień*. Leczenie razem działa lepiej niż osobno.

DLACZEGO TO DZIAŁA

ADHD jest jednym z **najsilniejszych** czynników ryzyka uzależnień. Wilens i wsp. (2011, meta-analiza): osoby z ADHD mają 1,5–2x wyższe ryzyko zaburzenia związanego z używaniem substancji (SUD). Mechanizm — *hipoteza samoleczenia* Edwarda Khantziana (1997): osoby z deficytami neurochemicznymi używają substancji, by je **regulować**. Nikotyna i kofeina stymulują (jak metylofenidat). Alkohol „wygasza” reaktywność emocjonalną. Marihuana „uspokaja gonitwę myśli”. **To nie wybór charakteru** — to mózg próbujący się *naprawić* dostępnymi narzędziami. Levin i wsp. (2007, RCT): leczenie ADHD jednocześnie z uzależnieniem jest bezpieczne i skuteczne. **Nie czeka się** na abstynencję — leczy oba.

01 Cztery typowe wzorce samoleczenia

STYMULACJA

Nadmiar kofeiny (5+ kaw), nikotyna, energetyki, stymulanty z czarnego rynku. Mózg szuka **dopaminy**, której ma za mało. Działa krótko, generuje tolerancję.

WYCISZENIE GONITWY MYŚLI

Marihuana, alkohol wieczorny, benzodiazepiny. **Pomaga zasnąć** albo wyłączyć „radio w głowie”. Cena: gorsza jakość snu, narastająca zależność.

REGULACJA EMOCJI

Alkohol „wygasza” wybuchy. Marihuana łagodzi reaktywność. Mózg nie potrafi sam — **zewnątrzny środek** jako protezę. Działa, ale uzależnia.

DOPAMINOWY „KOP”

Kompulsywne zakupy, hazard, pornografia, jedzenie. Substancje behawioralne — tzw. *uzależnienia behawioralne*. Ten sam układ nagrody, inny obiekt.

02 Cztery pytania kontrolne

Wzorowane na narzędziach przesiewowych (CAGE, AUDIT). Trzy „tak” lub więcej = wskazana konsultacja z lekarzem.

1 · PRÓBY OGRANICZENIA

Czy próbowałem/-am **zmniejszyć** używanie i nie udało się? Wracam do dawnej dawki w kilka dni?

2 · REAKCJA OTOCZENIA

Czy ktoś bliski **wyrażał niepokój** dotyczący mojego używania? Czy ukrywam ilość lub częstość?

3 · POCZUCIE WINY

Czy mam **poczucie winy** związane z używaniem? „Powinienem/-am mniej”, „wstyd mi przyznać, ile”?

4 · UŻYWANIE RANO / POMOC

Czy używam **od razu po wstaniu** — żeby „dojść do siebie” albo móc funkcjonować? To znak silnej zależności fizjologicznej.

03 Twój wzorzec — bez oceny, tylko fakty

Wypełnij bez analizy „dobre/złe”. To dane diagnostyczne. Pomogą Tobie i specjaliście/-tce zrozumieć, czego szuka mózg.

SUBSTANCJE, KTÓRYCH UŻYWAM

— wszystkie, łącznie z kofeiną

ILOŚĆ I CZĘSTOŚĆ

— konkretnie, dziennie/tygodniowo

PO CO SIĘGAM — FUNKCJA

— stymulacja / wyciszenie / regulacja / sen / nuda

KIEDY SIĘGAM — KONTEKST

— pora dnia, nastrój, sytuacja

04 Drogi pomocy — co działa

LECZENIE RAZEM, NIE PO KOLEI

Levin i wsp. (2007, 2015): leczenie ADHD **jednocześnie** z uzależnieniem daje lepsze rezultaty niż „najpierw abstynencja, potem ADHD”. Pacjenci nieleczeni z ADHD często wracają do substancji.

LEKARZ/-RKA ŚWIADOMY/-A OBU

Psychiatra/-tra znający/-a i ADHD i uzależnienia. Nie każdy/-a podejmuje się tej kombinacji. Pytaj o doświadczenie z „*dual diagnosis*”.

WSPARCIE SPOŁECZNE

Grupy AA/NA, grupy ADHD, terapia indywidualna. *Body doubling* trzeźwości — partner rozliczeniowy, do którego dzwonisz przy kryzysie. **Społeczność leczy.**

ZASTĘPCZE REGULATORY

Sen, ruch, posiłki, uważność (ang. *mindfulness*), terapia. **Mózg potrzebuje regulacji** — jeśli odbierasz mu substancję, zastąp ją czymś innym. Inaczej wraca po starsze rozwiązanie.

Klucz: Khantzian (1997): używanie substancji w ADHD *nie jest słabością charakteru* — to **próba samoleczenia** realnego deficytu neurobiologicznego. Wilens i wsp. (2011): odpowiednie leczenie ADHD *obniża* ryzyko uzależnień, a nie zwiększa. To *nieleczone* ADHD prowadzi do substancji, nie leczone. Jeśli rozpoznajesz u siebie wzorzec samoleczenia — to nie powód do wstydu, to *informacja*. Powiedz o tym lekarzowi/-rce. Leczenie razem działa. Sam/-a — najczęściej wraca.